获奖论文

特等奖

强化营养治疗降低肝硬化食管静脉曲张内镜治疗患者出血率

李长政 *
中国人民解放军火箭军总医院，北京市，西城区，100000

目的 肝硬化伴有食管静脉曲张接受内镜硬化治疗患者，在内镜治疗过程中会形成创面，若创面愈合不佳，甚至会出现治疗过程中的出血。本研究旨在探讨在肝硬化伴有食管静脉曲张接受内镜硬化治疗患者中，应用强化营养治疗对创面愈合和出血率的影响。

方法 自 2011 年 6 月至 2018 年 6 月在我院行内镜下硬化治疗的肝硬化食管静脉曲张患者共 496 例，其中 232 例采用一般性营养支持治疗，264 例采用强化营养治疗。每周 1 次内镜下硬化剂注射治疗直至静脉曲张消失或基本消失，比较两组患者食管溃疡创面愈合、内镜下渗血、以及显性出血情况的差异。

结果 强化营养治疗组有 261 例有治疗后复查内镜的资料，145 例可见治疗创面未愈合残留的溃疡，其中伴有出血的溃疡 14 例；对照组有 227 例有治疗后复查内镜的资料，205 例见创面溃疡，其中伴有出血的溃疡 36 例；强化营养治疗组创面溃疡率和伴有出血的溃疡率均低于对照组（P <0.001，P <0.001）。全组有 18 例发生临床显性出血（3.6%），其中强化营养治疗组 5 例（1.9%），对照组 13 例（5.6%），强化营养治疗组出血率低于对照组（P =0.031）。

结论 对于肝硬化伴有食管静脉曲张接受内镜下硬化治疗的患者，强化营养治疗可促进内镜治疗后局部损伤的愈合、减少治疗过程中创面出血的并发症。

一等奖

001

预测中国慢性乙型肝炎（CHB）患者接受丙酚替诺福韦（TAF）治疗的长期骨骼和肾脏结局

韩英 *[1]，吴斌[2]，胡明[3]，侯凤琴[4]，杨益大[5]，王磊[6]
1. 空军军医大学西京医院，陕西省，西安市，710000
2. 上海交通大学医学院附属仁济医院，上海市，虹口区，200000
3. 四川大学华西药物政策与药物经济学研究中心
4. 北京大学第一医院，北京市，西城区，100000
5. 浙江大学附属第一医院
6. 山东大学第二医院，山东省，济南市，250000

背景 中国慢性乙型肝炎感染负担较重，约有 9600 万名感染者。治疗目标是抑制病毒复制，以及实现丙氨酸氨基转移酶（ALT）复常，从而减少肝脏损伤和相关的肝脏并发症；但是，CHB 治疗可导致骨骼和肾脏不良事件的风险升高。本研究模拟了核苷（酸）类似物（NAs）治疗 10 万名中国 CHB 患者的长期骨骼和肾脏结局，并将 TAF 与富马酸替诺福韦二吡呋酯（TDF）和恩替卡韦（ETV）进行了对比。

方法 采用“患者动态模拟”预测 CHB 患者的终生健康结局。慢性肾病 3 期（CKDIII）和终末期肾病（ESRD）的风险评估基于特定治疗所致的肾小球滤过率（eGFR）的改变。将治疗方案所致骨

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net